관절은 붓는데 RF·항CCP가 정상이라면

혈액검사 수치가 오를 때까지 기다리지 않습니다

객관적 관절부종 확인

▼

≥6주 지속 · RF·항CCP·CRP 정상

▼

초기 X-ray 정상이어도 RA 배제하지 않기

▼

류마티스내과 의뢰 · 항체 상승을 기다리지 않기

홍석찬 연자 Q&A · 의뢰 판단

신체검진으로 확인한 객관적인 관절부종이 ≥6주 지속되면 RF·항CCP·CRP가 정상이어도 류마티스내과로 의뢰합니다. 질문 증례는 양측 PIP 부종·열감·압통과 조조강직이었습니다.

! 검사 해석

RF 양성만으로 RA 진단, 음성만으로 배제할 수 없습니다. RA 환자의 20~30%가 RF 음성입니다. 항CCP는 RF보다 특이도가 높지만 음성으로 배제하지 않습니다. 초기 RA는 X-ray에서 뚜렷한 이상이 없을 수 있습니다.

의뢰 시 함께 기록

부종 관절(MCP·PIP 포함), 지속 기간, 조조강직·대칭성, ESR/CRP와 RF·항CCP 결과/검사실 상한, X-ray 등 영상 결과를 정리합니다. 분류기준 점수는 진단 자체가 아니며 임상적 활막염이 출발점입니다.

RF·항CCP 결과를 읽는 법

임상 맥락과 검사실 상한 대비 역가

항체별 성능 · 강의 제시값

RF: 민감도 약 70%, 특이도 약 80%. 항CCP: 민감도 약 70~75%, 특이도 약 90~95%. RF 음성 RA의 약 40%에서 항CCP가 양성입니다. 높은 역가는 검사실 정상 상한의 약 3배 수준으로 제시했습니다(강의 예: RF <15, 항CCP <7).

RF 위양성 · 관절 이외 문진

고령, B/C형간염·결핵·심내막염 등 감염, SLE·쇼그렌에서도 RF 양성일 수 있습니다. 건강인 RF 양성은 20~60세 2~4%, 60~70세 5%, >70세 10~25%로 소개했습니다. 입·눈 마름도 질문합니다.

분류기준의 자리

2010 ACR/EULAR 분류는 다른 질환으로 설명되지 않는 ≥1관절의 명확한 활막염에서 적용합니다. 관절 침범 0~5점, 혈청검사 0/2/3점, ESR/CRP 0~1점, 지속기간 <6주 0점·≥6주 1점이며 총 ≥6/10점으로 분류합니다. 음성 혈청검사가 의뢰를 막지 않습니다.

항CCP 양성의 의미

발병 1~5년 전 양성일 수 있고 높은 역가는 진행 위험과 관련됩니다. 강의에 소개한 미분화 관절염 연구에서는 3년 내 RA 진행이 양성 >90%, 음성 25%였습니다. 미란성 경과·ILD·심혈관질환과의 연관도 설명했습니다.